

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	末期病人呼吸喘的照護 Palliative Care of Dyspnea In Terminal Cancer Patient				
編號	A31000-Q03-W-C04	制定者	緩和 林佩瑜	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.7 版/9 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解末期病人呼吸喘的照護定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

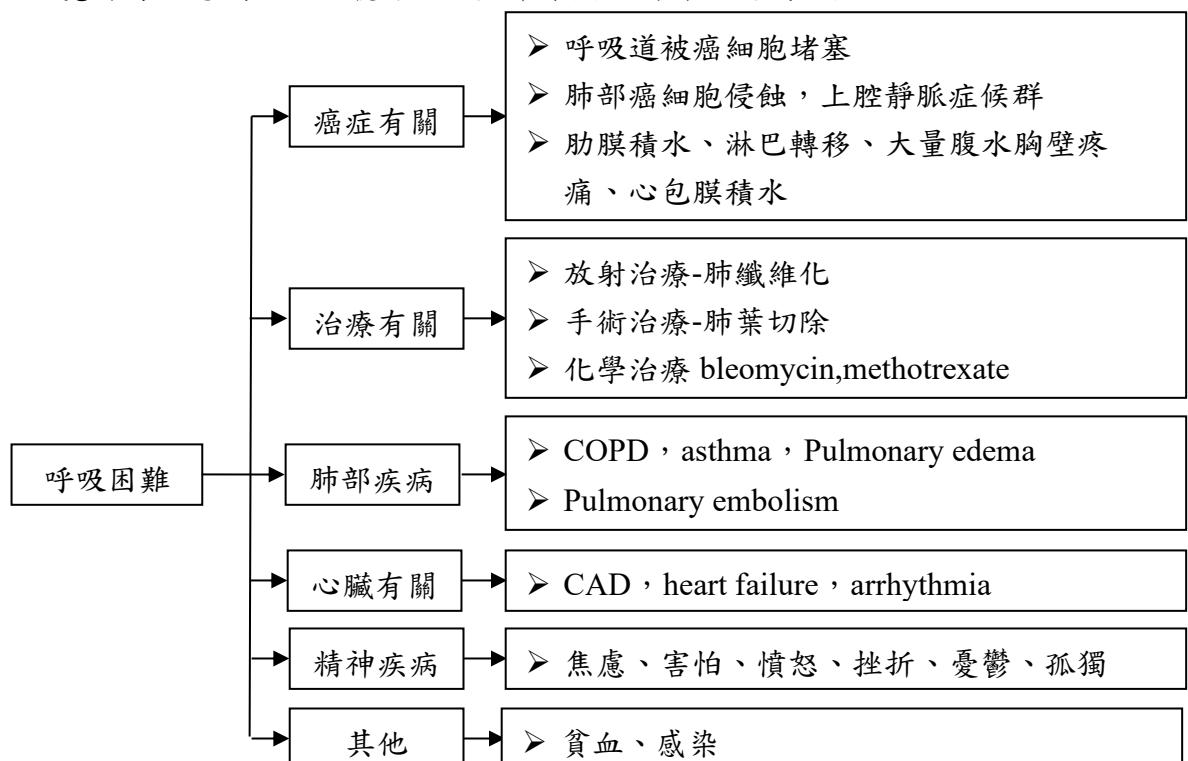
二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

為病人呼吸不舒服的主觀經驗，由各種強度不同的感覺構成。此經驗乃是引發生理和行為反應之生理、社會和環境因素的結合。病人常見的主訴為吸不到氣，並覺得有窒息感，而反覆呼吸困難常讓病人對存活更感恐慌。



主題名稱	末期病人呼吸喘的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/9

(二) 症狀

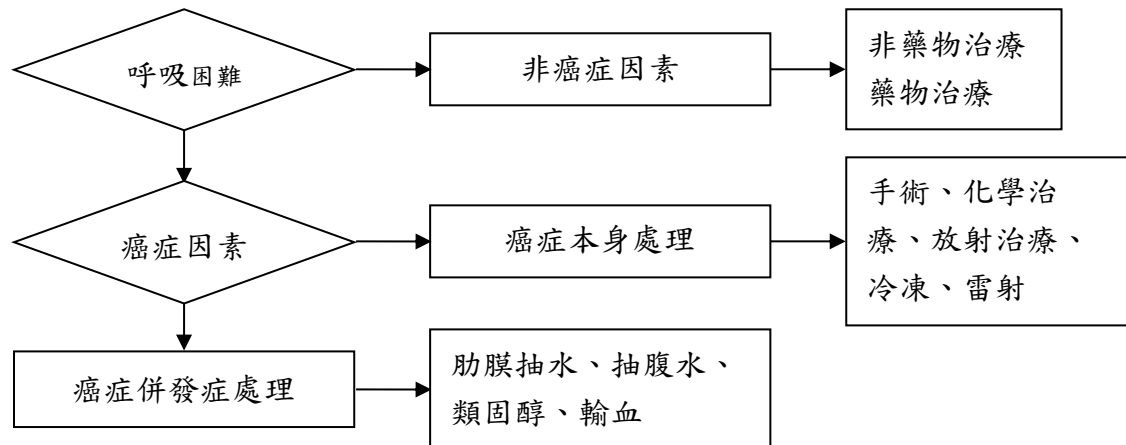
- 1.病人常見主觀的經驗描述，如呼吸短促、無法呼吸、呼吸不適或胸悶緊緻感。
- 2.在癌末病人常伴有焦慮或害怕窒息。

(三) 常見檢查

- 1.問診病史。
- 2.理學檢查和部分實驗室檢查：包含血色素、血氧含量及胸部 X 光。
- 3.斷層掃描可以適用於當胸部 X 光無法確診時。
- 4.評估：
 - (1) 病人的外觀、皮膚、指甲床和頰黏膜是否有發紺現象或出汗；呼吸的頻率、深淺及形式，胸廓之情況，如變形或不對稱。用力呼吸徵象：鼻翼扇動、張口呼吸、端坐呼吸、輔助肌使用、頸靜脈怒張等。
 - (2) 聽診呼吸氣音之音調、強度、時間及異常呼吸音，如 rales、crackle、wheezes、rhonchi、stridor 等。
 - (3) 觸診確認有無壓痛區、外觀之異常：腫瘤或結節、呼吸擴張之情形，如觸覺震顫、對稱性等。
 - (4) 叩診正常為低音調、反響，空氣滯留會出現過度反響，肺實質化、肋膜積水會出現濁音(dullness)。
 - (5) 其他：評估呼吸困難的臨床架構包含視覺類比量表(VAS)、過去呼吸困難的經驗、呼吸困難的描述、嚴重度、促成因素及並存的症狀、情緒的影響、功能的影響、社會適應的影響、行為調整。

主題名稱	末期病人呼吸喘的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/9

(四) 常見治療



(五) 護理問題

末期病人呼吸喘可能伴隨相關的護理問題如下：

1. 無法有效呼吸。
2. 疼痛不適。
3. 焦慮感受。
4. 身體活動能力異常。
5. 皮膚狀態不完整。
6. 排便異常：便秘。
7. 缺乏營養。

(六) 護理措施

1. 氧氣支持及護理，給予氧氣治療時應注意，高流速氧氣，必須使用潮濕裝置保持濕潤，以預防呼吸道黏膜出現乾燥現象。因 O2 面罩較容易引起病人不適，，口腔乾燥，同時也會造成言語溝通障礙，因此鼻套管供給病人氧氣，並在鼻子周圍塗抹水性潤滑劑減輕對粘膜的刺激是較舒適的方式。除了一般空調系統的使用外，電風扇的使用可以增加空氣對流，有學者認為涼風吹在病人的臉上可以刺激三叉神經的 cold receptor，改善呼吸型態和喘的感覺。
2. 藥物治療，如鴉片類藥物、支氣管擴張劑、類固醇、鎮靜劑使用及副作用監測。

主題名稱	末期病人呼吸喘的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/9

3. 自我呼吸控制：(1)噤嘴式呼吸：由鼻孔吸氣、再慢慢由噤起的嘴唇呼氣，呼氣時間應該比吸氣時間長 2-3 倍，其目的是在呼吸道造成一個負壓，以避免肺部過早塌陷，而使肺部中滯留的空氣能有效排出。(2)腹式橫隔膜呼吸：使橫隔膜的收縮更有效率。採半坐臥或仰臥姿勢，病人一手至於上腹部區域，一手置於前胸約心尖處，如此可以清楚感覺橫隔式呼吸起伏，當病人由鼻慢慢吸氣時，教導其使腹部肌肉突出，使橫隔膜能向下移動，當腹肌收縮的時候，再噤起嘴來用腹部力量呼氣，每做一分鐘休息兩分鐘。
4. 姿勢擺位包含胸腔物理治療，有姿位引流、胸腔扣擊、震顫、呼吸運動及有效咳嗽。姿位引流最常採用的五種姿勢為頭低、俯臥、左或右側臥和坐姿以引流各肺葉。中下肺葉支氣管引流可採頭低腳高姿勢，坐姿有利於排除上肺葉支氣管的痰液讓病人採坐姿，身體向前微傾，趴在桌子上，此時亦可準備各種枕頭，配合病人姿勢而給予適度的支撐，使病人能完全放鬆來調節呼吸。
5. 飲食方面建議給予少量多餐方式，並選擇流質或軟質，易吞嚥之食物。若病人活動舌頭有困難，協助以湯匙將食物送至舌後方以利吞嚥。預防吸入性肺炎如先吸氣、少量食物方式、病人吞嚥後則吐氣或咳嗽、每吃一口間隔半分鐘、睡前 2 小時內勿進食，以減少胃逆流。
6. 以輔助醫療及另類醫療來減輕不適：(1)芳香療法即是運用精油的作用，利用按摩、泡澡、吸嗅等方式進入體內，以達平衡精神、情緒，可以滴 5-6 滴精油在手帕或面紙或熱毛巾，深呼吸 2-3 次，另外也可以滴入 6-8 滴的精油在薰香台或薰香燈中，可以將香氣散發在 6 坪的空間。另外，藉由和基礎油調和，稀釋濃度比例宜在 2%-5%之間，即可用按摩方式直接使用於胸口，主要用於呼吸系統精油包含薰衣草、辣薄荷、茶樹、尤加利、檸檬，使用時應該注意到使用的劑量、途徑、禁忌症等問題。(2)冥想療法和輕柔音樂使用的目的是漸進式將肌肉放鬆，。(3)按摩是輕觸皮膚緩慢規律的撫觸手法讓病人放鬆，包含了按撫、撫摩、擦揉、深壓、搓揉、揉捏、震動以及拍打等。(4)研究顯示穴位按壓法可能是切實可行的護理措施，如肺經（雲門、中府、天府、俠白、尺澤、孔最、

主題名稱	末期病人呼吸喘的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/9

列缺、京渠、太淵、魚際、少商)、檀中、合谷、內關等。臨床按摩手法多不勝數，且按摩手法稍一轉變對病人亦有不同效果。

7. 當病人身體狀況還能支撐社會自我實現的時候，鼓勵病人把握生命意義；當病人自我實現逐漸崩落的時候，陪同他摸索未來的方向。引導病人做生命回顧、抒發內心深層真正的恐懼與遺憾、使其情緒壓力得以宣洩、並適時給予心理支持，以降低病人及家屬的焦慮，亦有助於病人心理圓滿之達成。

(七) 衛教指導

提供末期病人呼吸喘的照護之相關衛教指導至少包括以下幾項：

1. 成人拍痰須知。
2. 癌症疼痛。
3. 氧氣使用須知。
4. 呼吸衰竭。
5. 肋膜積水。
6. 如何為臥床的病人執行口腔護理。
7. 預防跌倒須知。
8. 翻身擺位。
9. 善終準備。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	末期病人呼吸喘的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/9

六、參考資料

- (一) Deborah, D., & Joshua, S.(2021) Assessment and management of dyspnea in palliative care. Retrieved from uptodate website
<http://www.uptodate.com/contents/assessment-and-management-of-dyspnea-in-palliative-care?source=machineLearning&search=SOB+care&selectedTitle=1%7E150§ionRank=2&anchor=H89104042#H89104042>
- (二) F Amos, B., & Stephanie, M.H. & Anne M W.(2021) Palliative care: The last hours and days of life. Retrieved from uptodate website
<http://www.uptodate.com/contents/palliative-care-the-last-hours-and-days-of-life?source=machineLearning&search=SOB+care&selectedTitle=6%7E150§ionRank=1&anchor=H194021020#H1024055721>
- (三) American cancer society (2008)・癌症護理(林素琴、林麗英、顏芳慧、蘇婉麗譯)・台北市：五南。(原著出版於2004)
- (四) 王英偉(2010)・安寧緩和醫療臨床工作指引(二版, 47-51頁)・台北：財團法人中華民國(台灣)安寧照顧基金會。
- (五) 石世明、邱宗怡(2006)・臨終心理照顧-花蓮慈濟心蓮模式・慈濟醫學, 18(4), 71-78。
- (六) 李和惠、林麗秋、黃玉琪、吳碧雲、蕭思美、楊婉萍、江令君、林貴滿、林靜琪、許譯瑛、謝春滿、杜玲、陳秀勤、劉清華、郭淑芬、李崇仁、蔡麗絲、張珠玲、羅夢伶、...、柯薰貴(2019)・內外科護理學(六版), 華杏。
- (七) 林靜幸、田培英、李書芬、藍菊梅、李筱薇、謝春滿、蔡家梅、吳書雅、李婉萍、曹英、高淑允、方莉、孫凡軻、李業英、王彩芷、陳翠芳(2022)・身體檢查與評估指引(第六版)・新北市：新文京。
- (八) 萬玉鳳、湯淑華、王英偉(2006)・芳香療法於安寧病房的運用・慈濟醫學, 18(4), 67-71。

主題名稱	末期病人呼吸喘的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/9

七、附件

(略)

主題名稱	末期病人呼吸喘的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	1.修改部份說明內容。 2.病患改為病人。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1. 修飾定義字詞及矯正錯字。 2. 醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	增修第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1. 第三項內容部份刪修，並加入實證參考資料。 2. 新增第六項參考資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.05.15	3.4	1. 第三項第五目之 5 壓瘡更改為壓力性損傷。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 05 月 15 日護理長會議通過;108 年 05 月 20 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	末期病人呼吸喘的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C04	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
110.08.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.5	1. 第三項第二、三、六目內容刪修。 2. 第三項第五、六目之護理問題修訂。 3. 刪除新增第六項參考資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	3.6	1. 第三項第六目之 4.、5.內容刪修。 2. 新增刪除第六項參考資料及順序。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	3.7	第三項第三目之 4、第六目之 2、3、5、6 內容修訂。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。